

## TEMA 5.8 • OFTALMOLOGÍA

## celulitis preorbitaria

PERFIL EUNACOM 6.02.1.030

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

## Ojo Rojo Profundo (Parte 2): Patología de Cámara y Órbita

- Además de la patología corneal, existen tres causas críticas de ojo rojo profundo (o periquerático) que deben ser reconocidas inmediatamente, dada su gravedad y el riesgo inminente de ceguera:
- **Uveítis**
- **Glaucoma Agudo** (Glaucoma de ángulo estrecho)
- **Endoftalmitis**

## 1. Uveítis

Es la inflamación del tracto uveal. Si afecta sólo al iris se denomina **Iritis**, y si afecta al iris y músculo ciliar se llama **Iridociclitis** (términos equivalentes a uveítis anterior).

- **Clínica:**
- - **Ojo rojo profundo.**
- - **Hipopion:** Presencia de pus/leucocitos decantados en la cámara anterior. Suele ser moderado.
- - **Efecto Tyndall:** Patognomónico al examen con lámpara de hendidura (se ven puntos blancos flotantes en el humor acuoso, similares al polvo flotando en un haz de luz).
- - Caída de la agudeza visual.
- - **Enoftalmo/Hipotensión ocular:** El ojo puede palparse discretamente "desinflado" o blando.
- - *No suele haber sensación de cuerpo extraño* (lo cual lo distingue de las queratitis).
- - Puede haber fotofobia y dolor, pero en grado leve o moderado.

## PERLA CLÍNICA EUNACOM

**Signo Pupilar en Uveítis:** La pupila en la uveítis reacciona clásicamente con **Miosis** (pupila pequeña).

- **Etiologías principales:**
- - **Infecciosas:** Virales (CMV, Herpes), Tuberculosis, **Sífilis**.
- - **Autoinmunes (Las más preguntadas):** Fuertemente asociada a las **Pelvispondilartropatías** (especialmente **Espondilitis Anquilosante**), Enfermedad Inflamatoria Intestinal, **Enfermedad de Behçet** y Artritis Juvenil Idiopática (Enf. de Still).
- **Tratamiento:** Consiste en el manejo de la causa base (ej. AINEs sistémicos en espondilitis) más el uso fundamental de **Corticoides tópicos** para apagar la inflamación intraocular severa.

## 2. Glaucoma Agudo (Glaucoma de ángulo estrecho)

Ocurre por el cierre abrupto del ángulo iridocorneal (zona de drenaje del humor acuoso), provocando una acumulación del líquido y elevación explosiva de la Presión Intraocular (PIO).

- **Clínica Clásica:**
- - **Ojo rojo profundo** + Dolor extremo y súbito.
- - **Hipertonía Ocular:** Al palpar gentilmente a través del párpado cerrado, el globo ocular se siente duro como una piedra comparado con el sano.
- - Síntomas neurovegetativos acompañantes frecuentes por el dolor severo (náuseas y vómitos).
- - Disminución abrupta de la agudeza visual.

## PERLA CLÍNICA EUNACOM

**Signo Pupilar en Glaucoma Agudo:** La pupila suele presentarse en **Midriasis media fija** (semimidriasis). No reacciona al reflejo fotomotor.

- **Diagnóstico confirmatorio:**

- - **Tonometría Ocular:** Muestra una PIO elevadísima (40-60 mmHg; valor normal es hasta 20 mmHg).
- - **Gonioscopia** (por el especialista): Objetiva el ángulo cerrado.
- **Tratamiento de Urgencia (Manejo Médico Inicial):**
- - Fármacos para disminuir la producción del humor acuoso: **Timolol** (betabloqueador local) o **Pilocarpina** (gotas mióticas tópicas).
- - Para extraer líquido por osmoterapia: **Acetazolamida** oral o sistémica y **Manitol** intravenoso.
- **Tratamiento Definitivo (Profilaxis Anatómica):**
- - **Iridotomía Láser:** Realizada por oftalmólogo; se perfora un minúsculo agujero en el iris para restablecer la comunicación y drenaje entre cámaras.

## 3. Endoftalmitis

Es una infección intraocular purulenta completa. Es la causa infecciosa **más grave** de ojo rojo profundo y tiene un catastrófico riesgo de pérdida definitiva del ojo.

- **Clínica:**
- - **Ojo rojo profundo** con un enorme e impactante nivel de compromiso inflamatorio general (quemosis, equimosis conjuntival).
- - Dolor extremo.
- - **Hipopion masivo** (puede abarcar casi toda la cámara anterior).
- - Severa turbidez visual y disminución de agudeza visual.
- **Contextos de Riesgo Clásicos:**
- 1. **Postquirúrgico Inmediato:** Es la presentación más clásica e importante, habitualmente ocurre como complicación a los pocos días de una **cirugía de cataratas**.
- 2. Traumatismo ocular penetrante profundo.
- 3. Complicación tardía y no tratada de úlceras o uveítis infecciosas severas.
- **Microbiología:**
- - Grampositivos dominan: **Staphylococcus coagulasa negativo** (*S. epidermidis*), **Staphylococcus aureus**, y *Streptococos*.
- - Gramnegativos en trauma clásico: *Pseudomonas aeruginosa*.
- **Diagnóstico y Abordaje Inicial:** Absolutamente clínico. Ante la mínima sospecha (dolor + hipopion en un postoperado de cataratas), se debe **derivar de urgencia vital oftalmológica**. *Jamás subestimar ni esperar evolución.*
- **Tratamiento Especializado:**
- - Punción y cultivo vítreo (por el especialista).
- - **Antibióticos Intravítreos de Urgencia** (Punción directa al humor vítreo): Esquema universal suele incluir **Vancomicina + Ceftazidima** para cubrir amplio espectro agresivamente. (El tratamiento general no es sistémico ni endovenoso).

## CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

## ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un niño de seis años consulta por edema y eritema palpebral derecho de dos días de evolución, precedido por una rinitis. Al examen hay edema y enrojecimiento del párpado superior e inferior derechos. Los movimientos oculares están conservados, la agudeza visual es normal y no hay proptosis ni dolor con los movimientos oculares. ¿Cuál es el manejo más adecuado?"

## EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para celulitis preorbitaria. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- La clasificación fundamental es celulitis preseptal versus orbitaria según la relación con el septum orbitario.
- Los signos de celulitis orbitaria son: proptosis, disminución de agudeza visual, oftalmoplejía, dolor con movimientos oculares, alteración pupilar y quemosis.
- Con cualquiera de los signos de celulitis orbitaria, el manejo es hospitalización con antibióticos intravenosos.
- La celulitis preseptal se maneja ambulatoriamente con amoxicilina-ácido clavulánico oral.
- La causa más frecuente de celulitis orbitaria es la sinusitis paranasal, especialmente etmoidal.
- Las complicaciones más graves de la celulitis orbitaria son trombosis del seno cavernoso y meningitis, que pueden ser mortales.

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CELULITIS PREORBITARIA)****PREGUNTA 1**

Un niño de seis años consulta por edema y eritema palpebral derecho de dos días de evolución, precedido por una rinitis. Al examen hay edema y enrojecimiento del párpado superior e inferior derechos. Los movimientos oculares están conservados, la agudeza visual es normal y no hay proptosis ni dolor con los movimientos oculares. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

- A)** Hospitalización con ceftriaxona intravenosa
- B)** Amoxicilina-ácido clavulánico oral y control estrecho ambulatorio
- C)** Corticoides tópicos y observación
- D)** Tomografía de órbita urgente y hospitalización
- E)** Antibióticos tópicos oculares y observación ambulatoria

**PREGUNTA 2**

Un adulto de cuarenta años con sinusitis maxilar de una semana de evolución consulta por edema palpebral derecho, proptosis y dolor al mover el ojo. La agudeza visual está levemente disminuida. Al examen hay quemosis. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Amoxicilina-ácido clavulánico oral y control en cuarenta y ocho horas
- B)** Hospitalización con ceftriaxona más vancomicina intravenosas y tomografía de órbita
- C)** Corticoides intravenosos para reducir la inflamación orbitaria
- D)** Derivación electiva al oftalmólogo en la próxima semana
- E)** Tratamiento de la sinusitis con descongestionantes y antibióticos orales

**PREGUNTA 3**

Respecto a la celulitis orbitaria, ¿cuál es la fuente infecciosa más frecuente que origina este cuadro y cuál es la complicación más grave que puede producir?

- A)** Trauma palpebral; complicación más grave es la endoftalmitis
- B)** Sinusitis paranasal etmoidal; complicación más grave es la trombosis del seno cavernoso
- C)** Dacriocistitis; complicación más grave es la ceguera unilateral
- D)** Conjuntivitis bacteriana; complicación más grave es la endoftalmitis
- E)** Blefaritis crónica; complicación más grave es el absceso subperióstico aislado

**RESUMEN: CELULITIS PREORBITARIA**

La celulitis orbitaria es una patología que el médico general debe saber clasificar y manejar de manera urgente. Se divide en dos tipos según la relación con el septum orbitario: celulitis preseptal y celulitis orbitaria propiamente tal. La celulitis preseptal es la infección que queda anterior al septum orbitario. Tiene buen pronóstico y puede manejarse ambulatoriamente con antibióticos orales como amoxicilina-ácido clavulánico. La celulitis orbitaria en cambio es la infección que penetra posterior al septum y compromete el tejido graso de la órbita. Es una infección grave con alto riesgo de complicaciones como trombosis del seno cavernoso y meningitis. La distinción entre preseptal y orbitaria es clínica y es la decisión más importante. Los signos que indican celulitis orbitaria son: proptosis, disminución de la agudeza visual, oftalmoplejia o paresia de los movimientos oculares, dolor con los movimientos oculares, alteración del reflejo pupilar, y quemosis. Con la presencia de cualquiera de estos signos, el cuadro se clasifica como orbitario. El tratamiento de la celulitis orbitaria requiere hospitalización con antibióticos intravenosos como ceftriaxona con vancomicina, con o sin metronidazol, y tomografía computarizada de órbita y cerebro para descartar absceso subperióstico o colección orbitaria que requiera drenaje quirúrgico. La causa más frecuente de celulitis orbitaria es la sinusitis paranasal, especialmente del seno etmoidal.